

--

Name: عبير السيد محمد علي National ID: 27710062102321	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٤/٠٩
٢٧٧٩٠٠٠٦٢١٠٠٢٣٢١
حاصله على بطوم تجاره
متروجة
انثى
مسنية
احمد عبدالحكيم شاكز عبدالحكيم
البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٩/٠٢



KS2549714

غير
السيد محمد علي
اش محمد اسماعيل البناارض اللواء
العجزة - الجيزة
٢٧٧ ١٠٠٦ ٢١٠٢٣ ٢١

٤٩



طلب علاج أول مرة / متكرر

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

إسم المريض رباعياً : عيبر السيد محمد علي
المحافظة : الجيزة
رقم البطاقة : 27710062102321 رقم التليفون : 01006319055
العمر (تاريخ الميلاد) : 06-10-1977 المهنة : ربه منزل

العنوان : ارض اللؤاء

تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-06-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالتثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالتثدي (مبادرة)

خطة العلاج : سونار وماموجرام على الثديين 10888 قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفى.

الاسم: د/احمد نجيب

الاسم: د/خالد عبدالعزيز

الاسم: د/محمد كيلاني

أطلعت اللجنة على لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د.أ /د /د

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :

ملاحظات :

قسم :

نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص



Residence Program for Women's Health
Ministry of Health and the Ministry of Planning

البرنامج السكني لصحة المرأة
وزارة الصحة والخطط



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : كبري العبدالله محمد علي

Sex:

3- Medical number:

Female

83233516

Old Med:

01000

324H-2024

2- ID number: 27710067102321

Patient Age: 42 Y



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone

01000319055

BMI

25

REASON OF MDT

REASON OF MDT
BUST 2024-04-14

marital status

Marital status
MARRIED

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP
1

Date of MDT

Date of MDT

2025-05-29

Comorbidity

Comorbidity
free

Menopausal
status

Menopausal status
Postmenopausal

Initial STAGE

Initial STAGE
T1N1M0

Clinical data

Breast Imaging :

lt UOQ 11 o'clock 3.5 x 2.1 cm x enlarged lt axillary LN

Mets Workup :

PAUS: suspicious focal lesion in the rt hepatic lobe

BX IDC	ER 7/8	PR 5/8	Her 2 Neu 0	SISH	Ki67 30
ER: positive	ER: positive	PR: positive	Her 2 Neu: negative	SISH: positive	Ki67: 30

T 4d	N 2	M
---------	--------	---

Sonomammography

PATIENT HISTORY

received NACT 4 cycle DDAC-->taxotere with good clinical response

LT MRM :multifocal IDC GII

free deep margin

YPT2(2.2CM)+ve LN 1/5

partial pathological response

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

PORT

ADJUVANT AI +/- ZOLADEX ACC TO FSH, E2

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

Patient Name : الأستاذ / عبير السيد محمد على

Patient No. : 27710062102321

Path No. : 1594/25

Sex : Female

Age : 47 Y

Referring Doc :

Request No. : 13001933

Request Date : 04/05/2025

Verification Date : 21/05/2025

Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة

Department : Out Patient

Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Left modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

* Procedure: Left MRM measured 25x16 cm with covering skin ellipse measured 25x15 cm.

* Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.

* Size: 2.2x2 cm at upper outer quadrant.

* Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.

* Distance from margins: 0.5 cm away from deep margin.

Rest of breast tissue revealed greyish white rubbery granular cut section.

* Separate axilla in the same container: Fibrofatty tissue measured 5x5 cm entangling 5 nodules.

Key :

1 and 2: TBS.

3: Deep margin.

4: Nipple and areola.

From 5 to 14: Granular area.

15 and 16: Lymph nodes.

Dissected by: Dr. Nermin Mohamed , Regross for lymph nodes by: Dr Yasmin Essam.

Microscopic Examination:

* Histological type: Multifocal invasive duct carcinoma.

* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II .

- Maximal tumor diameter (largest): 2.2x2 cm

- Actual tumor cellularity: 15%, tumor necrosis index: 85%

* Ductal carcinoma in situ: Not detected.

* Lymphovascular invasion: Present.

Verified by :

Dr.Menan Hossam

Printing Date : 29/05/2025 13:13:59

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / عيبر السيد محمد على

Patient No. : 27710062102321

Path No. : 1594/25

Sex : Female

Age : 47 Y

Referring Doc :

Request No. : 13001933

Request Date : 04/05/2025

Verification Date : 21/05/2025

Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة

Department : Out Patient

Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Microcalcification: Present.
- * Skin involvement: Free nipple & areola.
- * Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in lymph nodes 1/5 with largest metastasis diameter 0.2x0.2 cm.
- * Resection Margins: Free deep margin.
- * Histologic response to therapy: Pathological partial response.

Diagnosis:

Left breast cancer post NACT, MRM specimen:

Multifocal invasive duct carcinoma, Grade II.

- Maximal tumor diameter: 2.2x2 cm.
- Actual tumor cellularity: 15%, tumor necrosis index: 85%.
- Free deep margin.
- Free nipple & areola.
- Positive metastatic deposits in lymph nodes 1/5.
- Positive for lymphovascular invasion and calcification.
- Pathological partial response to therapy
- Stage: ypT2, ypN1
- RCB: 2.826, RCB class II.

Signature

Dr.Rana Fathy

Dr.Menan Hossam

Verified by :

Dr.Menan Hossam

Printing Date : 29/05/2025 13:13:59

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name: Abeer Al Sayed Mohamed Ali	Date: 23/09/2024
Exam: C.T ABDOMEN & PELVIS	Age: 47 Year(s)
Medical ID: 3248/2024	Pat. ID: 79410

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS:-

Findings:

Known case of left breast cancer

I Chest:-

- Left breast UIQ irregular deeply seated soft tissue mass lesion measures 34x27 mm with overlying skin thickening.
- Left axillary multiple pathological axillary lymph nodes (level I and II) the largest at left level I measures 18x30 mm.
- Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest at left lower basal posterior segment measures 7 mm.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Bilateral iliac enlarged reactionary lymph nodes.



Patient Name: Abeer Al Sayed Mohamed Ali	Date: 23/09/2024
Exam: C.T ABDOMEN & PELVIS	Age: 47 Year(s)
Medical ID: 3248/2024	Pat. ID: 79410

- > TUD is seen in place.
- > Right adnexal cyst is seen measuring 3x2 cm.
- > No abdominal or pelvic collections.
- > No sizable lytic or sclerotic bone lesions.
- > Right femoral sclerotic bone lesion likely bone island.

Opinion:

- Left breast UIQ mass lesion as described with ipsilateral axillary pathological enlarged lymph nodes.
- Bilateral pulmonary few indeterminate nodules for follow up.
- Right adnexal cyst, for pelvic ultrasound correlation.

Dr. Tasneem Selim

Dr. Reham Appal, FRCR, MD

?????, ??? Patient ID: 10110224015626 DOB: 06-Oct-1977 Date: 16-Dec-2024

Patient Lastname: السيد

Patient Firstname: عبيد

HIS Patient ID: 10110224015626

RIS Patient ID: 363461

Date of Birth: 06/10/1977

Procedure: 70030, Bone Scan

Medical Question:

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (16/12/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

" Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.

" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.

" Both kidneys are visualized.

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mahmoud Akram

Omnia Talaat, MD

===== REPORT TEXT ENDE =====



DMS
منزله من شمال والفعوصات
هزم من ار امه كس + زوكا كس
سول ركني دصو
مامو صرام

